

Task 1: Радикулопатія. Топічний діагноз(ok)

Відповідальний підрозділ: Кафедра неврології та нейрохірургії
Автори:

- 1. Гнатюк Ірина Михайлівна — розробка завдання , введення в електронну систему (відносна частка участі — 50%)
- 2. Солодовнікова Юлія Олександрівна — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)

Компетенції:
Мета завдання: Оцінити вміння встановлювати рівень ураження нервової системи.
Обладнання:

- 1. Неврологічний мотолоточок
- 2. Кушетка

Витратні матеріали:

№	Ім'я	Quantity per one task execution
1	Антисептик	10
2	Серветки паперові	10

Брифінг

Ви лікар-невропатолог у поліклініці. До Вас звернувся чоловік зі скаргами на біль у поперековому відділі хребта.

ok

Текст завдання

Ви лікар-невропатолог у поліклініці. До Вас звернувся чоловік зі скаргами на біль у поперековому відділі хребта.

- 1. Деталізуйте скарги та анамнез захворювання пацієнта.
- 2. Проведіть неврологічний огляд хворого з урахуванням основної скарги на біль у поперековому відділі хребта.
- 3. Вкажіть рівень ураження.

ok

Conditionally displayed materials:

1. Підзавдання - тригер: №18 (-Встановити попередній діагноз. Встановити рівень ураження.)

Чеклист

1. -Привітатися з пацієнтом Значення: 2.5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
2. -Назватися та запитати як можна звертатися до пацієнта Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
3. -Запитав "Що вас турбує?" Значення: 2.5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
4. -Уточнив як часто болить Значення: 5%	

☐ Не виконано	☐ Виконано
5. -Який характер болю (напр. ниючий, ріжучий, прострілюючий) Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
6. -Уточнив чи віддає біль кудись Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
7. - Попросив пацієнта показати де болить Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
8. -Запитав чи є відчуття оніміння, повзання мурашок по шкірі на нижніх кінцівках Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
9. -Запитав чи є відчуття слабкості у нижніх кінцівках Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
10. -Запитав чи є порушення функції тазових органів Значення: 4%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
11. -Чим провокується біль Значення: 3%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
12. -Запитати у пацієнта дозвіл на проведення неврологічного огляду Значення: 3%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
13. -Пояснити що ви зараз будете робити. Попросити пацієнта лягти на кушетку Значення: 6%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
14. -Перевірити м'язовий тонус на нижніх кінцівках Значення: 7%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
15. -Перевірити м'язову силу на нижніх кінцівках Значення: 7%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
16. -Перевірити сухожильні та періостальні рефлекси з нижніх кінцівок Значення: 8%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
17. -Перевірити патологічні рефлекси на нижніх кінцівках Значення: 7%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
18. -Перевірити поверхневу чутливість на нижніх кінцівках Значення: 8%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
19. -Встановити попередній діагноз. Встановити рівень ураження. Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

Інструкції для актора

№ п/п	Інтерн	Пацієнт
1.	Добрий день. Мене звати ... Як я можу до вас звертатися?	Добрий день. Мене звати Андрій.
2.	Що вас турбує на даний момент?	У мене болить поперек.
3.	Який характер болю? Наприклад, ниючий, стріляючий, пекучий тощо.	Як правило, це ниючий біль, але інколи може бути й стріляючий.
4.	Як часто ви відчуваєте біль?	Зараз кожного дня.
5.	Чи іррадією, чи віддає біль кудись?	Біль віддає у ліву ногу.
6.	Будь ласка, покажіть де саме Вас болить.	Пацієнт вказує на біль в попереку по центру, а далі проводить рукою по задній поверхні лівої ноги донизу до великого пальця на стопі.
7.	Чи є відчуття оніміння, повзання мурашок по шкірі на нижніх кінцівках?	Так, є відчуття оніміння та повзання мурашок по шкірі у лівій нозі.

8.	Чи є відчуття слабкості у нижніх кінцівках?	Так, в лівій нозі.
9.	Чи не з'явилися у Вас в останній час проблеми з сечовипусканням?	Ні.
10.	Чим провокується біль?	Біль провокується фізичним навантаженням.
11.	Що полегшує біль?	Біль полегшується, коли лягаю відпочивати.
12.	Коли вперше з'явився такий біль? Чи змінився біль протягом часу?	Такий біль періодично з'являвся протягом п'яти років, але постійним він став останні півроку.
13.	Чи приймали ви якісь ліки від цього болю? Чи полегшували вони біль?	Так, приймав мелоксикам, бетаметазон, і зазвичай ці ліки знімали біль. Але останні півроку нічого не допомагає.
14.	Чи дозволити мені провести Вам неврологічний огляд?	Так
15.	Інтерн проводить неврологічний огляд. З урахуванням ваших скарг, даних анамнезу захворювання та неврологічного огляду, я можу встановити, що ураження знаходиться на рівні тіл поперекових хребців S1-S2 – лівобічна радикулопатія S1	Під час перевірки чутливості по задній поверхні лівої ноги, пацієнт повинен вказати, що тут вона знижена. Зрозумів, дякую.

№ п/п	Інтерн	Пацієнт
1.	Добрий день. Мене звати ... Як я можу до вас звертатися?	Добрий день. Мене звати Андрій.
2.	Що вас турбує на даний момент?	У мене болить попереk.
3.	Який характер болю? Наприклад, ниючий, стріляючий, пекучий тощо.	Як правило, це ниючий біль, але інколи може бути й стріляючий.
4.	Як часто ви відчуваєте біль?	Зараз кожного дня.
5.	Чи іррадіює, чи віддає біль кудись?	Біль віддає у ліву ногу.
6.	Будь ласка, покажіть де саме Вас болить.	Пацієнт вказує на біль в попереку по центру, а далі проводить рукою по задній поверхні лівої ноги донизу до великого пальця на стопі.
7.	Чи є відчуття оніміння, повзання мурашок по шкірі на нижніх кінцівках?	Так, є відчуття оніміння та повзання мурашок по шкірі у лівій нозі.
8.	Чи є відчуття слабкості у нижніх кінцівках?	Так, в лівій нозі.
9.	Чи не з'явилися у Вас в останній час проблеми з сечовипусканням?	Ні.
10.	Чим провокується біль?	Біль провокується фізичним навантаженням.
11.	Що полегшує біль?	Біль полегшується, коли лягаю відпочивати.
12.	Коли вперше з'явився такий біль? Чи змінився біль протягом часу?	Такий біль періодично з'являвся протягом п'яти років, але постійним він став останні півроку.
13.	Чи приймали ви якісь ліки від цього болю? Чи полегшували вони біль?	Так, приймав мелоксикам, бетаметазон, і зазвичай ці ліки знімали біль. Але останні півроку нічого не допомагає.
14.	Чи дозволити мені провести Вам неврологічний огляд?	Так
15.	Інтерн проводить неврологічний огляд. З урахуванням ваших скарг, даних анамнезу захворювання та неврологічного огляду, я можу встановити, що ураження знаходиться на рівні тіл поперекових хребців S1-S2 – лівобічна радикулопатія S1	Під час перевірки чутливості по задній поверхні лівої ноги, пацієнт повинен вказати, що тут вона знижена. Зрозумів, дякую.